

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information – Patient Copy Subcutaneous Mastectomy

معلومات الإقرار – نسخة المريض استئصال الثدي مع الحفاظ على الجلد وملحقاته

1. What is a subcutaneous mastectomy?

The removal of all the breast tissue under the skin of the breast is called a subcutaneous mastectomy. The nipple and areola will be left in place. The breast will usually be flat after the operation.

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic. See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor. If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung

1. ماهو استئصال الثدي مع الحفاظ على الجلد وملحقاته ؟

إن إزالة كل نسيج الثدي الموجود تحت جلد الثدي يسمى "استئصالاً للثدي مع الحفاظ على الجلد وملحقاته". سيتم ترك الحلمة والمنطقة الدائرية حولها في مكانهما. يكون عادةً شكل الثدي بعد إجراء العملية مسطحاً.

2. التخدير الذي أتلقيه

يتطلب الإجراء الخضوع للتخدير. اقرأ تعليمات التخدير الموضعي والأدوية المسكنة المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج. إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ماهي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء ؟

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى، مما يتطلب العلاج بالضادات الحيوية وعلاجات أخرى
- قد يعقب أخذ العينة حدوث نزيف مما قد يتطلب إعادتك مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً إذا كنت ممن يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابير دامول (بيرسانتن أو اساسانتن)
- قد يحدث إنغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند المرضى ذو الوزن الزائد أو السمنة المفرطة، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر، مضاعفات

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

complications, and thrombosis.

- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- A collection of fluid may develop under the skin which the doctor may need to drain with a needle and this may have to be done several times.
- The edges of the wound may lose blood supply and change colour and may have to be excised.
- Depression of the nipple may occur due to adherence to the muscle.
- Healing of the wound may be abnormal and the wound can be thickened and red (a keloid scar) and the scar may be painful.
- All of the breast tissue may not be removed.
- Increased risk in smokers of wound and chest infections, heart and lung complications and thrombosis.

Notes to talk to my doctor about:

- في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم
- يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء
- من التجلط ليصل إلى الرئة.
- قد تحدث الوفاة كنتيجة للقيام بهذا الإجراء

مخاطر متعلقة بهذا الإجراء خصوصاً :

- قد تتجمع بعض السوائل تحت الجلد ، مما قد يحتم على الطبيب
- تجفيف هذه السوائل مستخدماً إبرة ، وقد يتطلب الأمر تكرار
- هذا الإجراء مرات عديدة.
- قد لا تتزود جوانب الجرح بالدم ويتغير لونها ، وقد يضطر
- الطبيب لإزالتها جراحياً.
- قد يحدث انخفاض في مستوى حلمة الثدي بسبب التصاقها
- بالعضلة.
- قد يلتئم الجرح بطريقة غير طبيعية ، وقد تزداد سماكة الجرح
- ويصبح أحمر اللون (تكون ندبة الجدة: وهي تليف للجلد يعقب
- الجروح) وقد تكون مؤلمة.
- عدم استئصال كل نسيج الثدي.
- عند المدخنين ، تزداد مخاطر عدوى والتهابات الجرح والصدر ، مضاعفات القلب والرئة ، و جلطات الأوعية الدموية.

أمور أتناقش مع الطبيب المعالج حولها :
